

Guia Digital da Rede de Atenção Psicosocial do DF

A rede pública de saúde mental existe, é gratuita e quase ninguém sabe usar. Isso é um problema de informação.

Yuri Victor de Oliveira e Silva

Ciência da Computação · Tecnologia e Inovação

ODS 3 · ODS 5 · ODS 16

A dimensão do problema

970 mi

de pessoas conviviam com algum transtorno mental no mundo em 2019 — cerca de uma em cada oito.

16,3 mi

de brasileiros adultos já receberam diagnóstico médico de depressão, o equivalente a 10,2% da população.

~2%

é quanto os países destinam, em média, do orçamento de saúde à saúde mental.

A rede já existe

A Reforma Psiquiátrica substituiu o modelo manicomial por um cuidado comunitário e territorial, hoje organizado na Rede de Atenção Psicossocial.

Lei nº 10.216/2001

Estabelece o tratamento preferencialmente em serviços comunitários de saúde mental.

Portaria nº 3.088/2011

Institui a RAPS, articulando CAPS, atenção primária, urgência e dispositivos territoriais.

No Distrito Federal

18 CAPS e 176 unidades básicas de saúde, com atendimento gratuito e sem necessidade de encaminhamento nos CAPS.

O PROBLEMA

O problema não é a ausência de política pública. É a distância entre a política que existe e a pessoa que precisa dela.

Uma lacuna de informação — que é exatamente o tipo de problema que a Ciência da Computação sabe resolver.

Questão de pesquisa

De que forma uma plataforma web *mobile-first*, construída a partir de dados públicos oficiais, pode ampliar o conhecimento da população do DF sobre os serviços da RAPS e facilitar o acesso a eles?

Objetivo geral

Desenvolver uma plataforma que organize e torne acessível a informação sobre os serviços da RAPS no Distrito Federal.

Alinhamento com os ODS

ODS 3 (metas 3.4 e 3.8), ODS 16 (meta 16.10) e, transversalmente, ODS 5 (meta 5.2).

Como a pesquisa foi feita

Pesquisa aplicada, de abordagem qualitativa, com objetivos exploratórios e descritivos.

Etapa	O que foi feito
Revisão bibliográfica	SciELO, LILACS, Periódicos CAPES, BDTD e bibliotecas de computação
Pesquisa documental	Levantamento dos pontos de atenção no CNES e nos portais da SES-DF
Pesquisa de campo	12 entrevistas semiestruturadas, amostra por conveniência, na Asa Sul
Avaliação (em curso)	Teste de usabilidade com tarefas e escala SUS

A coleta não abordou saúde, diagnóstico ou sofrimento pessoal dos participantes — apenas o conhecimento sobre serviços públicos.

O que as 12 entrevistas mostraram

Hipótese	Situação
Não sabem nomear serviços além de hospital e pronto-socorro	Confirmada
Desconhecem que o CAPS funciona em porta aberta	Confirmada
Quem buscou ajuda recorreu à rede privada ou a conhecidos	Parcial
A informação oficial está dispersa entre CNES e SES-DF	Confirmada
A terminologia técnica dificulta a compreensão	Confirmada
Após usar a plataforma, identificam o serviço adequado	Não testada

Substituir "a maioria" pelos números exatos das anotações antes de apresentar.

O ACHADO CENTRAL

O desconhecimento apareceu em um público com internet e escolaridade acima da média do DF.

Se acontece com quem tem acesso privilegiado à informação, o problema não é só socioeconômico: é de como a informação está organizada.

A solução

Uma plataforma web gratuita, pensada para o celular, que reúne o que já é público e traduz para quem precisa.

Serviços por região

Os pontos de atenção organizados por região administrativa, não pela lógica interna do sistema de saúde.

Linguagem simples

O que cada serviço faz, se precisa de encaminhamento e como chegar — sem jargão clínico.

Dados oficiais

Alimentada por CNES e SES-DF, com a data da última atualização sempre visível ao usuário.

Acessível e sem cadastro

Diretrizes WCAG, funcionamento em conexões lentas e nenhum dado pessoal coletado.

O que o projeto não faz

Não realiza triagem, diagnóstico, acolhimento ou acompanhamento psicológico.

A literatura registra mais de dez mil aplicativos de saúde mental nas lojas, sem evidência de eficácia proporcional. A plataforma organiza informação pública e encaminha às pessoas aos serviços competentes — nada além disso.

Amostra

12 participantes, não probabilística. Sem inferência estatística.

Território

Asa Sul. Não representa as regiões periféricas do DF.

Tempo

Um semestre letivo, sem segunda rodada de coleta.

A rede existe, é gratuita e quase ninguém sabe usar

A lacuna é informacional, não de oferta. E isso é um problema que a computação sabe resolver, desde que saiba onde parar.

Próximos passos

Concluir o levantamento no CNES, desenvolver a plataforma e aplicar o teste de usabilidade com a escala SUS.

Continuidade

Replicar a escuta em regiões periféricas e investigar como medir o impacto de intervenções digitais informacionais.

Publicação

Submissão prevista à Revista de Extensão (UNESC), Qualis B1 no quadriênio 2021-2024.

Precisa de ajuda? CVV 188, 24 horas e gratuito. SAMU 192.